



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هاجر خلف عبدالحميد ابوقلته
المحافظة : المنيا
الحى / المدينة : ملوي
رقم البطاقة : 27912182401561 رقم التليفون : 01117648905
العنوان : ابو قلته
العمر (تاريخ الميلاد) : 18-12-1979 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- / د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هاجر خلف عبد الحميد ابو قلته National ID: 27912182401561	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية

ماجر
 خلف عبد الحميد حسن
 ابوقينه
 مركز ملوي بمحافظة المنيا

٢٧٩ ٢٢ ١٨ ٢٤ - ١٥ ٦١
 IX1459147

٢٠٢١/٠٦ ٢٧٩١٢١٨٢٤-١٥٦١
 ربة منزل

التي مسلمة متزوجة
 عائل ربيع نجيب محمود
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٦/٠١

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

هاجر
خلف عبد الحميد حسن
ابو قلته
مركز ملوي - القليوبية

٢٧٩١٢١٨٢٤٠٦٥٦١

IX1459147

٢٠٢١/٠٦/٠١ ٧٨١٢١٨٢٤٠١٥٦١

ربة منزل

أنثى
مسلمة
متزوجة
عادل ربيع نجيب محمود

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٦/٠١

٦

Name: هاجر خلف عبدالحميد			
MR. : 9207			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		بقسم:	رقم طبي:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
46 YEARS OLD FEMAE PT WITH LT BREAST CANCER MUCINOUS CARCINOMA ER 8/8 PR 4/8 HER2-VE KI6740% CT2N2 RECEVIED 3AC+3TXT LT WLE+ALND 26/1/2021 YPT2YPN1 LN 2/9 PORT TAM +ZOLADEX SINCE 1/2021 TO 2023 AI SINCE 2023 FOR SM PAUS CXR FULL LAB FEMARA CALIUM 1*1*90 ONE ALPHA SM >>4/2026 >> FREE E2 LEVEL >>R FOR FEMARA FOR 3 MONTHS			
تحريرا في ,			
التاريخ :		19-09-2026	
الوقت :		ايه مدحت بدوي محمد	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			



24-8-2020
Name: فاطمة بنت عبد الله

Age: 40

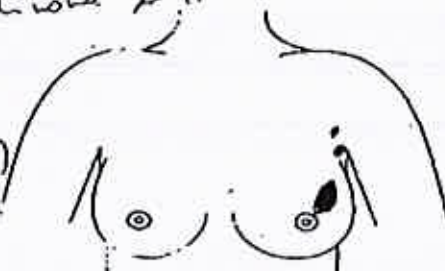
No.:

Last cycle

MDT FORM

Clinical data:

Left Breast Ca IDC ^{mucinous 2nd T}
CT₂ 4x5cm CN₂ (multiple Ax.)
No (CT)



ER 818

PR 418

HER -ve

Ki67 = 40%

Reason of discussion:

Breast scan
Echo lab
clip insertion

MDT Outcome and Plan

for neoadjuvant chemo then BCS & ALND

Re MDT (26/12/2020) - pt. finished chemo, sm. Response
for TCSM 4. Re MDT.

Signature:

 د. فاضل
مدير العيادة
STC


26/12/2020

MDT 16/11/21
Left Breast
for wire


24-1-21



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m3846

Female	النوع	ماجر خلف عبد الحميد حسن	اسم المريض
القاهرة	العنوان	41 Y	تاريخ
21/07/2020 08:42	تاريخ استلام العينة	مركز اورام دار السلام	تاريخ اخذ العينة
28/07/2020 10:24	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل
			ملاحظة

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by: -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong continuous nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
PR: moderate nuclear staining of 5 % of tumour cells (core biopsy)
HER2/neu protein over expression : No membrane staining of tumor cells. (core biopsy)
Ki67: positive nuclear staining of about 30 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)
PR: POSITIVE (SCORE 4/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE
*KI67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 30 %

Pathologist:

د/نوريزا ماهر

Lab Director: د/نوريزا ماهر

Pathology Report

Name: *Amal El Chay*

Clinical data: Left breast mass

Age: 32 years

Specimen type: Tru cut biopsy

Date: 12/7/2020

Lab Number: 974

Hospital Number: 2303/2020

Gross Description

Five greyish white tissue cores, 0.8 cm each, totally submitted.

Microscopic Examination

Histopathological examination of section prepared revealed breast tissue infiltrated by malignant tumor, formed of clusters of moderately anaplastic ductal epithelial cells, floating in pools of mucin, with hyperchromatic pleomorphism.

Diagnosis:

Left breast mass, tru cut biopsy;
Mucinous carcinoma GII, for IPT; (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Essam

Prof. Dr. Gamal Abdel-Azy

Mohamed Ali

Patient name: Hager Khalaf Abdel Hamid

Date: 14/2/2022

Bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indications:

- Patient has left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The right breast is almost entirely fatty (ACR A) .
- Post-operative sequel of the left breast int the form of:
 - ✓ Diffuse skin thickening.
 - ✓ UOQ asymmetric density with related distortion , corresponding by U/S to operative bed thick branching hypoechoic scarring with related marked parenchymal distortion.
- No right suspicious microcalcifications or spiculated masses
- No solid or cystic lesions on the right breast
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts, of the right breast.
- Bilateral Nonspecific axillary LNs.

Opinion:

- Post left CBS status showing operative bed changes with related marked parenchymal distortion ? post-operative , better for U/S follow up after 6 months.
- Unremarkable study of the right breast (BIRADS 1).

Yours truly,

Dr. Peter Fahmy

Name : Hagar Khalef Abdelhamid

Date : 11/8/2020

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST
ABDOMEN & PELVIS REVEALED:**

Known case of cancer breast:

1. Chest:

- Left breast ill-defined mass is seen measuring about 4.1 x 2.8 cm with multiple left axillary (level I and II) lymph nodes the largest is seen measuring about 1.4 x 1.7 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture with tiny right hepatic lobe segment VIII (dome) hyperdense focal lesion measuring about 9 x 7 mm.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Cholecystectomy surgical clips.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No abdominal or pelvic collections.

OPINION:

- *Known case of breast cancer showing left breast mass with left axillary lymphadenopathy.*
- *Hepatic dome hyperenhancing focal lesion likely rapid filling hemangioma.*
- *No pulmonary metastatic deposits.*

Dr. Ahmed Rozeka, MSc

Dr. Amr Farouk, MD

Exam : C.T CHEST

Medical ID:

Age : 44 Year(s)

Pat. ID: 11739

MULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest with multiplanar reconstruction. No IV contrast was used.

FINDINGS:

Status follow up, in reviewing the previous study report dated 8-5-2025, the current study showing:

- Left breast diffuse skin thickening.
- Left upper lobar and lingual thin reticulations likely post therapeutic sequel.
- Bilateral basal fibrotic parenchymal bands
- No sizable pulmonary nodules, consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- CT signs of cardiomegaly for echo correlation.
- Upper abdominal cuts show cholecystectomy clip.

Opinion:-

- ❖ No current CT evidence of sizable metastatic pulmonary nodules.

Dr. Nourhan Mohamed, MD

Dr. Nourhan Mohamed, MD

Summary: Post left CBS and ALAND followed by radiotherapy, routine follow up study

Right Breast:

Post entirely fatty breast parenchyma. (ACR a)
No architectural distortion with no speculations, masses asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
Normal skin/nipple/areola complex.
No axilla-specific axillary LNs.

Left Breast:

Post entirely fatty breast parenchyma. (ACR a)
Thickened skin and coarsen trabeculae.
No architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
Ultrasound demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar.
Well defined partly solid hyper-echoic lesion with related macrocalcifications.
Thickened skin reaching 5 mm and coarsen trabeculae.
Normal nipple/areola complex.
No axilla-specific axillary LNs. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

Right Breast (BIRADS 1): Normal study.

Left Breast (BIRADS 2): Post-therapeutic changes with fat necrosis.

DR. Israa Reda, M.Sc.

Ahram Scan

October Branch, Bone Densitometry Unit
Phone: () - - - - - Fax: () - - - - -

DXA Bone Densitometry Report: Wednesday, February 02, 2022

or (not specified).

ar patient HAGER KHALAF A.ELHAMEED completed a BMD test on 2/2/2022 using the Lunar DPX DXA System (analysis
sion: 14.10) manufactured by GE Healthcare. The following summarizes the results of our evaluation.

PATIENT BIOGRAPHICAL:

me:	HAGER KHALAF A.ELHAMEED,				
lient ID:	400302	Birth Date:	12/1/1979	Height:	154.0 cm
nder:	Female	Exam Date:	2/2/2022	Weight:	63.0 kg
ications:		Fractures:		Treatments:	

ASSESSMENT:

: BMD measured at AP Spine L1-L4 is 0.753 g/cm² with a T-score of -3.6. This patient is considered osteoporotic according to
rld Health Organization (WHO) criteria. Fracture risk is high. Pharmacological treatment, if not already prescribed, should be
ted. A follow up bone density test is recommended in one year to monitor response to therapy.

h a Z-score of -3.5, this patient has very low BMD for their age and sex. Causes of secondary bone loss should be investigated.

h a Z-score of -1.3, this patient's BMD is low for someone of this age.

h a Z-score of -0.6, this patient's BMD is within normal limits for their age and sex.

h a Z-score of -1.5, this patient's BMD is low for someone of this age.

RECOMMENDATIONS:

F Guidelines recommend all people with T-scores of -2.5 and below (osteoporosis) consider taking an osteoporosis medication.
ective therapies are available in the form of bisphosphonates (Fosamax and Actonel), Miacalcin, Evista, and Forteo. All patients
uld ensure an adequate intake of dietary calcium and vitamin D. The NOF recommends adults under age 50 need 1,000 mg of
cium and 400-800 IU of vitamin D daily. Adults 50 and over need 1,200 mg of calcium and 800-1,000 IU of vitamin D daily.

FOLLOW-UP:

ple with diagnosed cases of osteoporosis or at high risk for fracture should have regular bone mineral density tests. For patients
gible for Medicare, routine testing is allowed once every 2 years. The testing frequency can be increased to one year for patients
o have rapidly progressing disease, those who are receiving or discontinuing medical therapy to restore bone mass, or have
ditional risk factors.

ed on these results, a follow-up exam is recommended in February 2023

cerely,

t specified)